جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : احلام محمد محمود عبد الفتاح
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** مركز الجيزه **العنوان :** =
رقم البطاقة : 27007152301061 **رقم التليفون :** 01144137249 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 15-07-1970 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: احلام محمد محمود عبد الفتاح
National ID: 27007152301061

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية

بطاقة تحقيق الشخصية



احلام

محمد محمود عبدالفتاح

٢٨ش خلف متفرع من ش المأمون

الجيزة - الجيزه

٢٧٠٠٧١٥٢٣٠١٠٦١

KI3995109



٢٧٠٠٧١٥٢٣٠١٠٦١ ٢٠٢٣/١٢

بدون عمل

انثى مسلمة ارملة

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/١٢/٢٣



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	:	Request No	: 13006076
Patient No.	: 27007152301061	Request Date	: 21/02/2022
Path No.	: 493/2022	Verification Date	: 06/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	:
Age	: 51 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

- Additional pathologic findings: Free nipple and areola, no microcalcification

Diagnosis:
Left breast cancer, Left MRM.
- DCIS, low grade with only one focus of invasive duct carcinoma, grade II (2 mm)
- Free nipple, and areola
- Free deep margin
- Positive metastatic deposits in 1/16 axillary lymph nodes with extracapsular extension
- ypT1 YpN1 ypMx

Prof Dr. Aml Harredy

Dr Walaa Ghonaim

Verified by :
walaa ghoniem

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: احلام محمد محمود **MR. :** 4937	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient has a diagnosis of breast cancer and has been receiving hormonal therapy with Femara for three months; bilateral mammography and bone scan are pending.

The patient has a left breast cancer, clinical stage T4b N2, with pathology showing estrogen receptor 8/8, progesterone receptor 6/8, HER2-negative, Ki-67 30%, and a recurrence after three lines of therapy. The treatment history includes prior therapy initiated in February 2022, left mastectomy with reconstruction, and adjuvant therapy completed in March 2022. The current plan includes continuation of Zometa, ongoing Femara, and pending bilateral mammography and bone scan.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : nada mohamed elsayed

يعتمد ,

Patient Name	:	Request No.	: 13006076
Patient No.	: 27007152301061	Request Date	: 21/02/2022
Path No.	: 493/2022	Verification Date	: 06/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	:
Age	: 51 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Left breast cancer, post chemotherapy

Nature of the specimen:
Left MRM, collected at 20/2/2022, 2 PM.

Gross Examination:
- Procedure:Left MRM specimen; measured 25x23x5 cm, skin covering 27x18 cm, skin, nipple and areola were unremarkable grossly
- Localization: N/A
- Tumor extent
  - Number:Ill defined gralysh white tumor bed site
  - Size: 1.7x1.5x0.5 cm
  - Skin involvement: No
- Distance from margins: 3 cm from skin and 1.5 cm from deep margin
- Lymph nodes number and size: 16 nodules up to 3 cm
- Additional pathologic findings: No
- Immunohistochemistry technique: N/A
- Frozen section N/A

Microscopic examination:
- Histological type DCIS, low grade with one focus of IDC, grade II (2 mm)
- Angioinvasion: Positive
- Ductal carcinoma in situ: Positive
- Lymph node involvement: Positive metastatic deposits in 1/16, with extracapsular infiltration, one node showed perinodal tumor lymphatic emboli.
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Verified by :
walaa ghoniem

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	:	Request No	: 13006076
Patient No	: 27007152301061	Request Date	: 21/02/2022
Path No	: 493/2022	Verification Date	: 06/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	:
Age	: 51Y	Department	: Out Patient
Refereing Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

- Additional pathologic findings: Free nipple and areola, no microcalcification

Diagnosis:
Left breast cancer Left MRM
- DCIS, low grade with only one focus of invasive duct carcinoma, grade II (2 mm)
- Free nipple, and areola
- Free deep margin
- Positive metastatic deposits in 1/16 axillary lymph nodes with extracapsular extension.
- ypT1 YpN1 ypM0

Prof.Dr. Amal Hamdy

Dr.Walaa Ghonaim

Verified by
Walaa ghonaim

Printing By : marwa mohamed youss

Printing Date : 06/03/2022 12:38:53

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: Abdul Mohammad Mahmood
Date: 10/09/2021

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. *Chest:*
   - Left breast upper outer quadrant irregular speculated enhancing mass lesion with spicules reaching the nipple which appears retracted and associated diffuse left breast skin thickening. measuring 5 X 3.5 cm.
   - Left axillary level I and II pathologically enlarged lymph nodes the largest measures 2.8 X 2 cm.
   - No sizable pulmonary nodules.
   - No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
   - No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
   - Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
   - Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
2. *Abdomen and pelvis:*
   - The liver is enlarged with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
   - Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
   - No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
   - Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
   - No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
   - Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes. Right renal large cortical cyst.
   - Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
   - Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
   - Normal appearance of the other pelvic organs.
   - No abdominal or pelvic masses or collections.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
- Misty mesentery surrounding the superior mesenteric artery associated with prominent lymph nodes suggestive of mesenteric panniculitis.

OPINION:

- *Left breast malignant looking mass lesion with metastatic ipsilateral axillary lymph nodes as described.*
- *No definite pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.*
- *Element of mesenteric panniculitis.*

Dr. Mohammed Mohsen, MSc.

Dr. M. Gadhia, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Health Insurance Organization
East City Cancer Center
(NCCC)

2021/8/1 :

Immunohistochemistry report

Lab.No:21/850

Procedure:

Sections immune stained for ER, PR, Ki67 and Her2neu using superseasitive monoclonal antibodies with Roche envision (Dextran substrate polymer) flex detection system. Pretreatment for heat induced epitope retrieval (HIER) was performed using flex target retrieval solution. Blocking of endogenous peroxidase was performed using Roche peroxidase blocking reagent DAB was used as a chromate.

Results:

ER: (8/8)

PR: (6/8)

Her2: Negative , score=0

Ki67: 30%.

N.B: the slides are delivered to the patient.

Prof.Dr.Hussain El Sayed

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

MDT FORM

23/3/2022

Name	أحلام محمد محمود	MRN	٤٠٤١٠٢٧٥٩
		ID	٢٧٨٠٠٧٥٢٠٢٦٠١
Age	54	Phone	٠١٠٦٩٧٥٢٠٩٦
Menopausal status	Perimenopausal	marital status	
OCP		Family history	-ve
Co morbidity	HTN		

Clinical Data

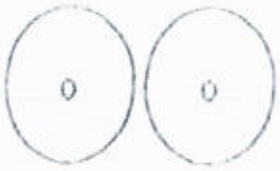
Dx: IDC-II

ER: 81	PR: 7/8	HER 2: -ve	Ki67: 30%

Sonomammography:

Mets Workup: - cTs Free
- Bone scan

R L



YpT1 N M0 1/12

Recommendations: - pT reimed NACT 3 FEC + 3 Taxotere
- pT HER+ ALND xpT1 N1/12 Ho cT Bone
- partial response
- Dexa - scan

MDT OUTCOME & PLAN (1) for post operative radiotherapy to
(2) Hormonal therapy AI with assessment of [illegible]

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]